評価の説明

※以下の評価基準は公的なものではありません。一般的な基準をもとに作成しています。

1. 指標別：評価点（スコアリング）構成表

各指標（0～4点）の算出基準と、その数値が示す現場の状態です。

点数	病床利用率（安定性）	病床稼働率（現場負荷）	病床回転率（効率性:月間）	指標の解釈（ニュアンス）
4点	90%以上	95%以上	2.5回以上	卓越： 地域の需要を独占し、極限までリソースを活用。
3点	85%以上	90%以上	2.0回以上	優良： 理想的な運用。収益と質のバランスが最適。
2点	75%以上	80%以上	1.5回以上	標準： 平均的。大きな問題はないが、改善の余地あり。
1点	60%以上	70%以上	1.0回以上	低迷： 活気が不足。空床や滞留の兆候が見られる。
0点	60%未満	70%未満	1.0回未満	

2. 合計点・ランクと【AI診断】対応表

合計点から算出される総合ランクと、AIがその「点数の組み合わせ」から読み取る診断内容です。

ランク	合計点	AI診断ニュアンスの代表例	診断の視点（AIロジック）
S	11～12	【超高効率】地域の中核として完璧な稼働。	全指標がトップ。現状維持が最大の課題。
A	8～10	【急性期特化】回転は速いが空床が目立つ。	病床回転率の点数が高い ＝ 腕は良いが、集患が課題。
		【地域密着型】安定しているが患者が滞留気味。	病床利用率の点数が高い ＝ 信頼はあるが、退院支援が課題。
B	5～7	【機能過剰】運用能力は高いが需要不足。	病床回転率の点数は高いが病床利用率が低い ＝ 紹介元営業を。
		【停滞傾向】満床に近いが入れ替わりがない。	病床利用率の点数は高いが病床回転率が低い ＝ 長期入院の是正を。
C	2～4	【固定化リスク】病床は埋まっているが機能不全。	病床回転率がほぼゼロ。療養への機能転換を検討。
		【低活動】集患と運用の両面に課題あり。	全指標が平均以下。体制の抜本的見直し。
D	0～1	【構造改革対象】存続の危機。早期の判断を。	経営維持が困難なレベル。事業再編の対象。

3. 分析を読み解くための「AI視点」ガイド

AIが診断を下す際に重視している「乖離（ギャップ）」の読み解き方です。

①病床回転率の点数 ＞ 病床利用率の点数（腕はあるが患者がいない）
②技術や効率は高いが、紹介患者の確保（営業活動）が不足している「宝の持ち腐れ」状態。
③病床利用率の点数 ＞ 病床回転率の点数（患者はいるが腕が遅い）
④地域に根ざしているが、退院調整が遅れてベッドが「詰まっている」状態。収益の伸び代はここにある。
⑤病床稼働率の点数 ＞ 病床利用率の点数（忙しいだけで実入りが少ない）
②入院・退院の事務手続きやベッドメイクの負荷が高い割に、夜間の実入院患者数が伸びていない「非効率」な状態。

4. 各指標の計算式と評価

病床利用率	計算式： 一日平均入院患者数／病床数（許可病床または稼働病床×100 一般的に「分母：動かせるベッドの数」に対して「分子：実際に使われたベッドの数（延べ患者数）」が どれくらいかを算出するものです。 90%以上【満員御礼】 地域からの需要が極めて高く、常に満床に近い状態。収益性は最大化されているが、 緊急入院の受け入れ余力が少ない。 85%以上【理想的運用】 安定した経営。適度な空床があり、効率と安全性のバランスが最適。 75%以上【標準的】 特筆すべき問題はないが、空床コストが発生している。集患対策の余地あり。 60%以上【低迷】 稼働にムラがある。病床の役割（診療科など）が地域のニーズとズレ始めている可能性。 60%未満【閑散】 赤字リスクが高い。病床削減や機能転換（一般から療養へなど）の検討が必要。
病床稼働率	計算式：（一日平均入院患者数 ＋ 一日平均退院数）／病床数×100 「退院当日の空床（入れ替えによる稼働）」を評価に含めた実質的な稼働率を算出しています。 この計算式は、現場の「忙しさ」や「ベッドの回転」をより正確に反映させるためのものです。 95%以上【フル稼働】 退院と入院の隙間がほとんどない。現場のオペレーション能力が極めて高く、 1床あたりの収益効率が最大化されている。 90%以上【高効率運用】 ベッドメイクと次の受け入れがスムーズに連携できている。急性期病院として理想的な回転速度。 80%以上【標準的運用】 現場に無理のないペース。急な入院にもある程度対応可能な余裕がある。 70%以上【低活動】 入院準備に時間をかけすぎているか、そもそも次の患者が待機していない。効率改善の余地が大きい。 70%未満【停滞】 ベッドが動いていない。運用の仕組み（クリニカルパス等）の見直しが必要。
病床回転率（回/年）	計算式：年間新入院患者数／病床数 ※計算式（近似式）：（一日平均入院患者数 ×365）／平均在院日数÷病床数 今回は正確な「新入院患者数」のデータが直接得られないため、近似式で算出しています。 さらに1/12して月間回転数として算出 2.5回以上／月（30.0 以上／年）【超高速循環】 1ベッドに月2.5人以上が入院。急性期機能が極めて高く、次々と 新しい患者を受け入れている。 2.0回以上／月（24.0 ～ 29.9／年）【高効率運用】 適切なサイクルで患者が入れ替わっている。経営効率が非常に良い理想的な状態 1.5回以上／月（18.0 ～ 23.9／年）【標準的】 一般的な一般病棟のペース。無理のない範囲での回転。 1.0回以上／月（12.0 ～ 17.9／年）【長期化傾向】 患者が滞留気味。リハビリ転院や在宅復帰の調整が遅れている可能性。 1.0回未満／月（12.0 未満／年）【停滞・固定化】 患者がほとんど入れ替わっていない。慢性期（療養）に近い運用実態。
病床回転間隔	計算式：（病床数×日数×延べ入院患者数）／退院患者数 ※計算式（近似値）：（365÷年間病床回転率） － 平均在院日数 今回は正確な「退院患者数」のデータが直接得られないため、近似式で算出しています。 0.5日～1.0日未満【極めて効率的】 退院後、即座に次の患者が入院している状態です。稼働率は非常に高いですが、 清掃やベッドメイキング、スタッフの余裕がなくなる「超過密」な状態と言えます。 1.0日～2.0日【標準的・良好】 一般的な急性期病院が目標とすべき範囲です。ベッドの準備時間を確保しつつ、 経営ロスを最小限に抑えられている評価になります。 3.0日以上【要改善】 ベッドが数日間空いたままの状態が常態化しています。「入院予約の管理」や 「前方連携（紹介患者の受け入れ）」に課題があるとみなされ、経営効率が悪化しているサインとなります。 ◇急性期病棟: 回転が速いため、1日前後を目指すのが一般的です。 ◇療養・慢性期病棟: 入院期間が長いため、1回あたりの空床期間の影響は急性期ほど大きくありませんが、それでも 2～3日以内に抑えることが健全経営の目安となりま
平均在院日数と 病床利用率の関係	計算式：延べ在院患者数／（新入院患者数＋退院患者数））÷2 病院経営の理想は、「平均在院日数の短縮」と「病床利用率の維持・向上」を同時に実現することです。 医療の質の向上、地域連携、診療報酬（DPC制度等）など複合的な観点からの取り組みが必要。

【出典】GemMed　株式会社WorkVision　大塚商会　コトセラ　群馬県済生会前橋病院

※今回は病床利用率、病床稼働率、病床回転率の3つの指標から評価しましたが、実際の病院経営の現場では、さらに別の指標を追加して分析がなされています。なお、地域の独自性を考慮し、例え評価点が低くても必要とされる病院はあります。簡易的なベンチマークだとご理解ください。

制作者名：Mana48FanClub
メールアドレス：mana48.hmc.club001@ymail.ne.jp
最終更新日：2026年3月